Introducción a la Unidad 7

Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 7: Manejo del paciente agitado. Elaborada por Dr Álvaro Jeria Durán, Médico Psiquiatra, Clínica Universidad de los Andes.

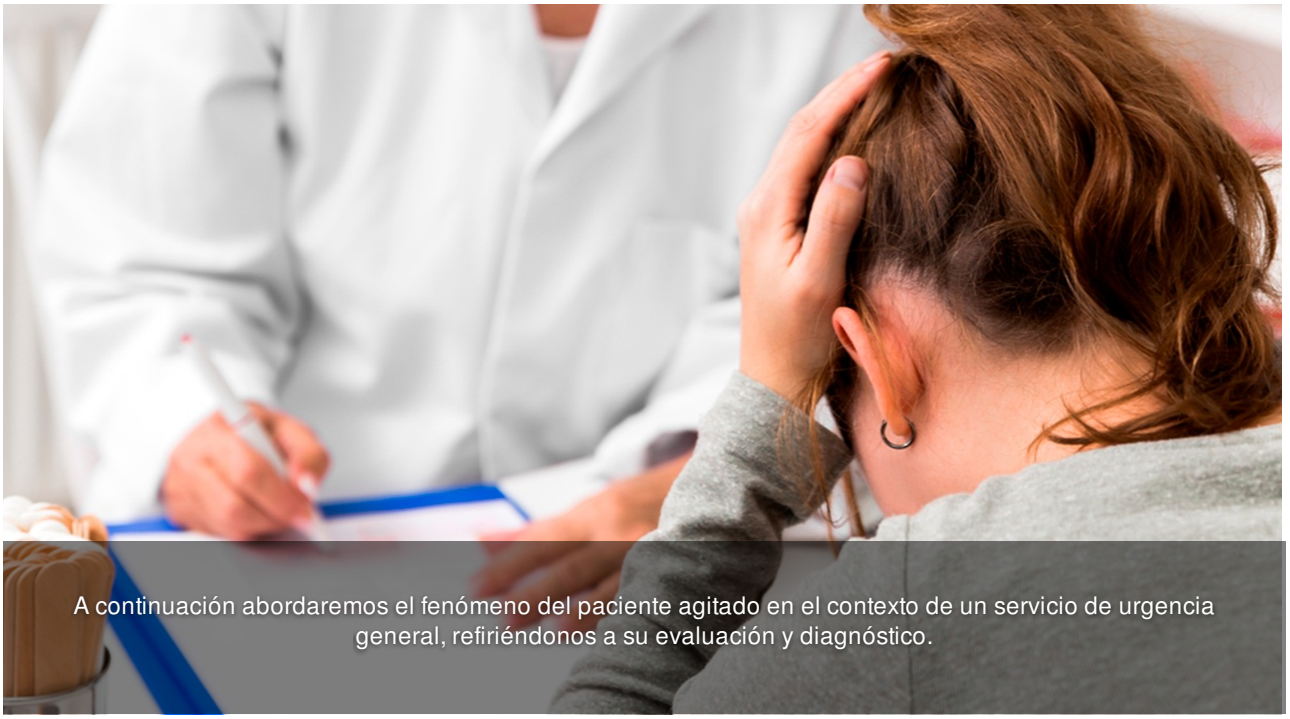
Objetivos de la unidad:

- Comprender la definición y causas de la agitación psicomotora.
- Revisar la evaluación, diagnóstico diferencial y manejo del paciente agitado en el servicio de urgencia.

Temas de la unidad:

- Paciente agitado en el servicio de urgencia.
- Manejo General de la Agitación.

Paciente agitado en el servicio de urgencia



A continuación abordaremos el fenómeno del paciente agitado en el contexto de un servicio de urgencia general, refiriéndonos a su evaluación y diagnóstico.

Uno de los desafíos más difíciles para un equipo de salud es enfrentarse al paciente que, pese a requerir evidentemente una atención de urgencia, se muestra violento o agitado. Si a eso, además, le agregamos que es una situación tensa y emocionalmente perturbadora para todos los involucrados, y eso ocurre en ambientes de alta carga laboral, estresantes per sé (como podrían ser los servicios de urgencias en cualquier lugar del mundo), sin duda que se trata de una situación extrema para la cual el equipo de salud debe estar preparado.

Hay estimaciones en la literatura médica que hablan de un 5-10% de riesgo de agitación de los pacientes que consultan en un servicio de urgencia.

En un estudio realizado a más de 40 mil atenciones de urgencia en Estados Unidos, se evidenció una prevalencia de 2.6% de agitación, lo que sin duda representa un porcentaje significativo del quehacer clínico de urgencias. Un 10% de los pacientes con agitación psicomotora, además, presentan compromiso cuali-cuantitativo de conciencia. (Miner et al, 2018)[1].

Es fundamental recalcar que la sola presentación de un cuadro de agitación psicomotora no traduce por sí misma la presencia de una patología psiquiátrica, y -más aún- en NINGÚN caso descarta la existencia de una patología orgánica no-psiquiátrica, sino que todo lo contrario: se trata de una urgencia médica, y debe guiar a los equipos de salud a una evaluación rápida de causas orgánicas potencialmente letales, pero teniendo en consideración el sufrimiento del paciente que padece este cuadro, en balance con la seguridad del equipo de salud y su entorno.

Se trata de una situación de distress para el paciente, sus familiares, pero también de una situación potencialmente peligrosa para el equipo de salud e incluso otros pacientes que se encuentren en el servicio de urgencia. Proteger la seguridad de todos los involucrados debe ser una prioridad al momento de enfrentarse al paciente agitado en el servicio de urgencia.

En este sentido, el diagnóstico posiblemente "psiquiátrico" subyacente a un episodio de agitación psicomotora debe ser considerado una vez que los demás cuadros hayan sido razonablemente descartados, y sin perder de vista el enorme riesgo de estigma, discriminación y pobre atención de salud que sufren las personas que viven con enfermedades mentales, algo que es susceptible de corregirse a través de la educación del equipo de salud[2].

Existe evidencia de que las personas que padecen una patología mental severa tienen una mayor morbi-mortalidad que la población general, ocurriendo en muchos casos un fenómeno que se ha denominado el "oscurecimiento diagnóstico", en que síntomas físicos son erróneamente atribuidos a la patología psiquiátrica, cuando en realidad corresponden a enfermedades orgánicas no-psiquiátricas, llevando al error del equipo médico en el cuidado oportuno del paciente[3].

Este fenómeno es, en gran medida, fruto de la falta de formación de los equipos médicos en la correcta detección de cuadros orgánicos no-psiquiátricos que ocurren en pacientes que -coincidentemente- tiene patologías psiquiátricas a la base.

Durante la presente unidad abordaremos el fenómeno del paciente agitado en el contexto de un servicio de urgencia general, refiriéndonos a la evaluación, diagnóstico y algunas sugerencias respecto a su manejo, y con un especial énfasis en fomentar la sospecha clínica de la patología orgánica-no psiquiátrica en todo paciente que consulta por agitación en la urgencia.

Agitación Psicomotora: Definiciones, Evaluación y Diagnóstico Diferencial

La agitación psicomotora es un síndrome clínico, que se define como la presencia de un aumento de la actividad motora, llegando a ser excesiva, y asociada a una sensación de tensión interna; esta actividad puede ser repetitiva y no productiva, como el balanceo o movimientos atípicos de las manos (DSM-5, APA 2013)[4].

Si bien es cierto que la agitación psicomotora no es un sinónimo de agresión y violencia, el progreso de la sintomatología puede llevar a dichas conductas, con el consiguiente riesgo para el paciente, su entorno, y -por supuesto- el equipo de salud.

En general se produce en un continuo, en que inicialmente el paciente presenta inquietud o leve exaltación, que aumenta a agitación para finalizar en la agresión y violencia de la conducta agitada.

Las causas de la agitación psicomotora son múltiples, y quizás lo más relevante es que puede ser secundaria a condiciones médicas que se asocian a una alta morbi-mortalidad, y que cubren prácticamente la medicina completa; también se deben considerar: patologías psiquiátricas descompensadas, ingesta de sustancias exógenas (intoxicación, drogas de abuso), o incluso factores sociales, como víctimas de violencia o personas viviendo en Situación de Calle.

> La agitación es, muchas veces, una respuesta del paciente a la percepción de estímulos externos, que mezcla emociones muy diversas que van desde el miedo a la rabia."
>
> *New et al, 2017.*

En la Tabla 1: Diagnóstico Diferencial de la Agitación Psicomotora se resumen algunas de las patologías que se deben tener en consideración al evaluar a un paciente cursando con una agitación psicomotora (ver tabla 1).

El principal error de los equipos clínicos es utilizar la presentación clínica de la agitación psicomotora como un sinónimo de “enfermedad mental” o “psicosis”, pues al hacerlo inevitablemente se activan constructos culturales asociados al estigma y la discriminación hacia las personas que padecen enfermedades mentales, poniendo en riesgo al paciente y al equipo médico de no diagnosticar oportunamente condiciones médicas (no-psiquiátricas) potencialmente letales. Pese a ello, cabe destacar que de los pacientes cuyo motivo de consulta es relacionado a la salud mental y psiquiatría, entre un 20 y un 50% podrían estar en riesgo de presentar una agitación psicomotora en la sala de urgencias[5].

Tabla 1: Diagnóstico Diferencial de la Agitación Psicomotora	
Neurológico	- Accidente Vascular Encefálico - Accidente Isquémico transitorio - Hemorragias: subdural/intraparenquimatosa/subaracnoidea -Delirium -Tumor -Infecciones SNC: encefalitis, meningitis -Demencias
Cardíaco	-Síndrome Coronario Agudo -Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) -Miocardiopatía -Arritmia -Pericarditis, miocarditis, endocarditis
Vascular	-Disección aórtica -Aneurisma Aórtico Abdominal -Isquemia Mesentérica -Estenosis carotidea -Isquemia Vertebrobasilar

Tabla 1: Diagnóstico Diferencial de la Agitación Psicomotora

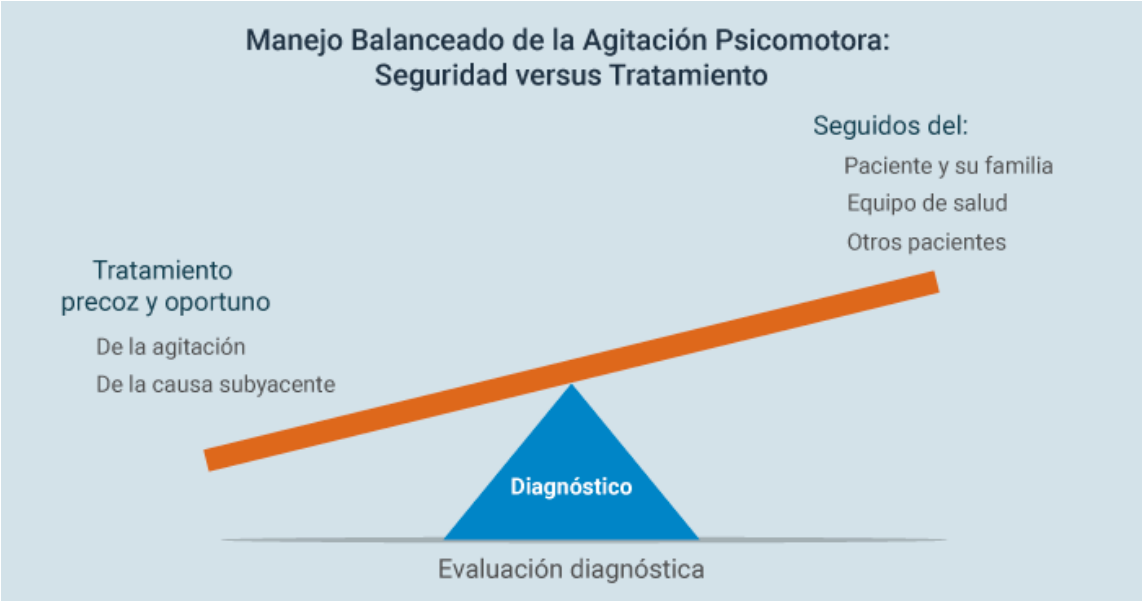
Pulmonar	-Neumonía -Tromboembolismo pulmonar (TEP) -Derrame pleural -Neumo/hemotórax -Fractura Costal
Gastrointestinal	-Hemorragia digestiva -Neumoperitoneo -Diverticulitis -Apendicitis
Genitourinario	-Infección tracto urinario (ITU) -Pielonefritis -Urolitiasis
Toxicológico	-Intoxicación: drogas de abuso (OH, Cocaína, Estimulantes, Drogas químicas, marihuana), tóxicos generales (p. Ej. pesticidas, raticidas, etc.) -Sobredosis (accidental vs intencional) -Efecto adverso de medicamentos (p. ej. anticolinérgicos)
Endocrinológico	-Tormenta tiroidea -Mixedema -Crisis addinsoniana -Crisis miasténica
Electrolitos	-Hipo/HiperNatremia -Hipo/HiperCalcemia -Etc.
Infeccioso	-Sepsis secundaria a ITU, neumonia, etc. -Cualquier foco infeccioso
Ambiental	-Hipo/Hipertermia -Deshidratación
Psiquiátrico	-Psicosis -Uso de sustancias, síntomas de abstinencia -Trastorno de Personalidad

Adaptada de Psychiatr Clin North Am. 2017 Sep;40(3):397-410

Es importante dedicar espacio a comprender el enfrentamiento de la agitación psicomotora en el setting de urgencias, sobre todo considerando que dos tercios de los médicos declaran no haber recibido ningún entrenamiento en este tema, y que apenas un 20-40% de los hospitales cuentan con un protocolo o programa de formación y manejo de agitaciones[6].

En este sentido se debe balancear en un mismo acto (ver Figura 1):

- Evaluación diagnóstica (entrevista, examen físico, laboratorio).
- Seguridad del paciente y su familia.
- Seguridad del equipo de salud.
- Seguridad de otros pacientes.
- Inicio precoz de medidas terapéuticas que el paciente requiera: de la agitación propiamente tal (contención verbal y manejo farmacológico), y de la causa de base en caso de ser secundaria a enfermedad orgánica.



La evaluación de la Agitación Psicomotora es eminentemente clínica. Se han estudiado múltiples herramientas para su evaluación, con diversos resultados.

Un ejemplo es la Escala de Evaluación de Agitación y Sedación de Richmond (en inglés RASS), desarrollada en 2012, y que consiste en una escala de 10 puntos que puede evaluar rápidamente (por 3 pasos claramente definidos) a un paciente, y ubicarlo en un nivel de sedación o agitación[7].

Escala de agitación y sedación de Richmond (RASS) en español

Puntuación	Término	Descripción
4	Combativo	Abiertamente combativo o violento. Peligro inmediato para el personal.
3	Muy agitado	Se retira tubo(s) o catéter(es) o tiene un comportamiento agresivo hacia el personal.
2	Agitado	Movimiento frecuente no intencionado o asincronía paciente-ventilador.
1	Inquieto	Ansioso o temeroso pero sin movimientos agresivos o vigorosos.
0	Alerta y calmado	
-1	Somnoliento	No completamente alerta, pero se ha mantenido despierto (más de 10 segundos) con contacto visual, a la voz (llamado).
-2	Sedación ligera	Brevemente, despierta con contacto visual (menos de 10 segundos) al llamado.
-3	Sedación moderada	Algún movimiento (pero sin contacto visual) al llamado.
-4	Sedación profunda	No hay respuesta a la voz, pero a la estimulación física hay algún movimiento.
-5	No despierta	Ninguna respuesta a la voz o a la estimulación física.
1. Observe al paciente: ¿El paciente está alerta y calmado? = puntuación 0. ¿El paciente tiene un comportamiento que sugiere inquietud o agitación? (puntuación de +1 a +4 según los criterios antes mencionados, bajo la descripción).		
2. Si el paciente no está alerta, en voz alta llame al paciente por el nombre y pídale que abra los ojos y lo observe. Repítalo una vez si es necesario. Puede solicitarle al paciente que continúe observándolo. El paciente tiene apertura de ojos y contacto visual, la cual se mantiene durante más de 10 segundos (puntuación de -1). El paciente tiene apertura de ojos y contacto visual, pero esto no se mantiene durante 10 segundos (puntuación de -2). El paciente tiene cualquier movimiento en respuesta a la voz, excluyendo el contacto visual (puntuación de -3).		
3. Si el paciente no presenta respuesta a la voz, estimular físicamente al paciente por medio de la agitación del hombro y luego frotando su esternón si no hay respuesta a la agitación del hombro. El paciente tiene cualquier movimiento a la estimulación física (puntuación -4).		
El paciente no presenta respuesta alguna a la voz o la estimulación física (puntuación -5).		

Fuente: Obtenida de Rojas-Gambasica, J. et al. Validación transcultural y lingüística de la escala de sedación y agitación Richmond al español. Revista Colombiana de Anestesiología. 2016, 44(3), 216-221.)

Otra herramienta útil para el clínico que desea realizar una buena evaluación en ausencia de tiempo es la escala Confusion Assessment Method (CAM), que tiene una sensibilidad del 94-100% y una especificidad de 90-95% para la identificación del Delirium .

Esto, pues son los pacientes que cursan con agitación en contexto de un Delirium los que suponen una señal de alarma para el equipo de salud, por las posibles complicaciones médicas subyacentes.
Habitualmente estos pacientes presentarán alteraciones atencionales y cognitivas, con fluctuaciones del estado de conciencia, haciendo que la contención verbal sea menos efectiva.

Existe evidencia que demuestra que este grupo de pacientes presenta una tasa mayor de efectos adversos, con 6 veces más intubaciones, 2 veces más hipotensión y 2 veces más hospitalizaciones, al compararlos con pacientes con agitación pero sin delirium; y, además, presentando una mortalidad que puede llegar al 16.5% (Miner et al, 2018).

Escala CAM[8]

1. Comienzo agudo y curso fluctuante

¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del paciente? ¿La conducta anormal fluctúa durante el día, alternando períodos normales con estados de confusión de severidad variable?

2. Inatención

¿Tuvo el paciente dificultad en enfocar la atención, por ejemplo, estuvo distraído o perdió en algún momento el hilo de lo que estaba diciendo?

3. Pensamiento desorganizado

¿Tuvo el paciente pensamientos incoherentes o mantuvo una conversación irrelevante, poco lógica o con ideas poco claras; o inexplicablemente cambió de tema de conversación?

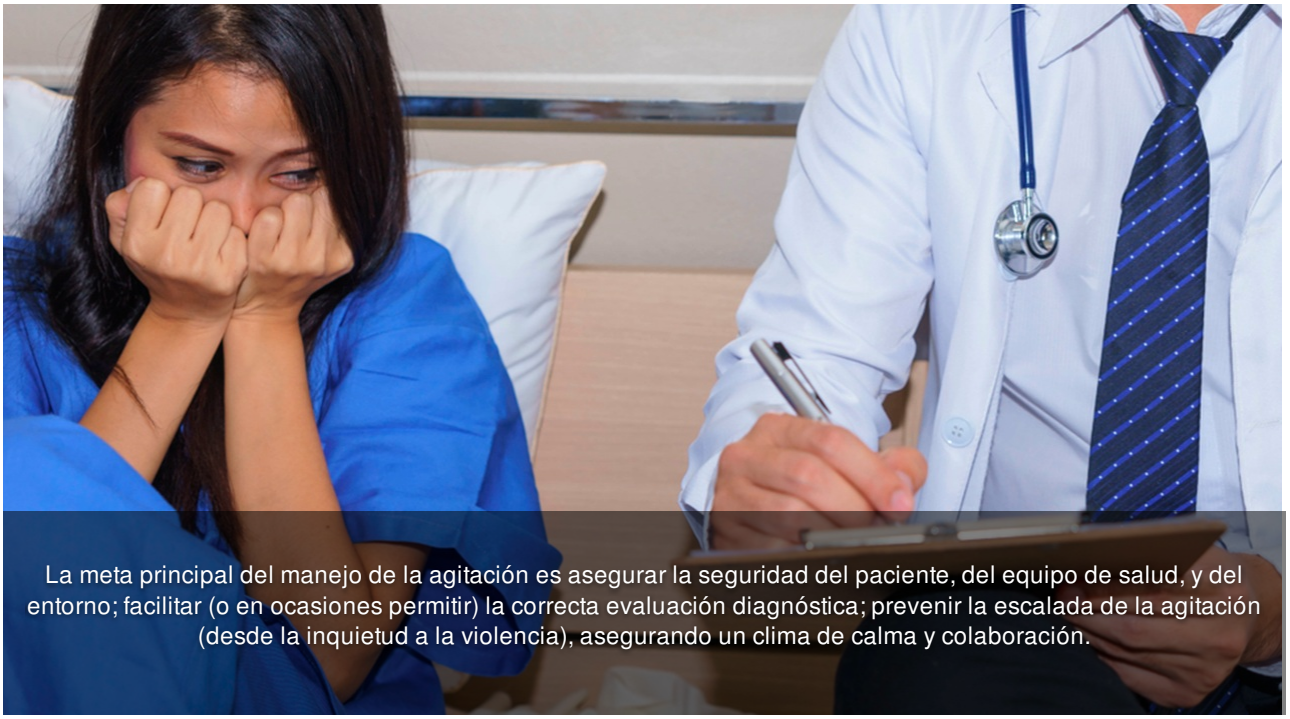
4. Alteración de conciencia

Observando al paciente, se considera normal al estado ALERTA.
Estados anormales:
VIGILANTE (hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales).
SOMNOLIENTO (fácilmente despertable).
ESTUPOROSO (difícil de despertar) COMA (imposible de despertar).

DELIRIUM

Características 1 y 2 y características 3 ó 4. Para el diagnóstico de delirium se exige: la presencia de los criterios 1 y 2, más uno de los siguientes (3 ó 4): 1 y 2 + (3 ó 4).

Manejo General de la Agitación



La meta principal del manejo de la agitación es asegurar la seguridad del paciente, del equipo de salud, y del entorno; facilitar (o en ocasiones permitir) la correcta evaluación diagnóstica; prevenir la escalada de la agitación (desde la inquietud a la violencia), asegurando un clima de calma y colaboración.

El objetivo de la intervención farmacológica, que debe ser considerada caso a caso, será ayudar a alcanzar esa calma y colaboración en el menor tiempo posible[1].

El manejo de la agitación será también el tratamiento de la causa subyacente a ella. Eso puede significar enfrentar situaciones médicamente graves, como hipoglicemias severas, hipoxia, delirium, y muchas otras causas, que cubren prácticamente todo el saber médico.

En su gran mayoría, los pacientes que a la base presenten enfermedades orgánicas no-psiquiátricas se presentarán con agitación y confusión, configurando un delirium o síndrome confusional agudo.

Es fundamental, entonces, no perder de vista la necesidad de un diagnóstico precoz, sobre todo de aquellas causas rápidamente reversibles, por lo que se sugerirá siempre realizar de manera rápida:

- Control de signos vitales, incluyendo oximetría de pulso.
- Hemoglucotest.
- Un adecuado examen neurológico, considerando particularmente estado de conciencia y posibles signos de focalidad neurológica
- Exámenes rápìdos cuando estén disponibles (por ejemplo: Point of Care Testing, POCT).

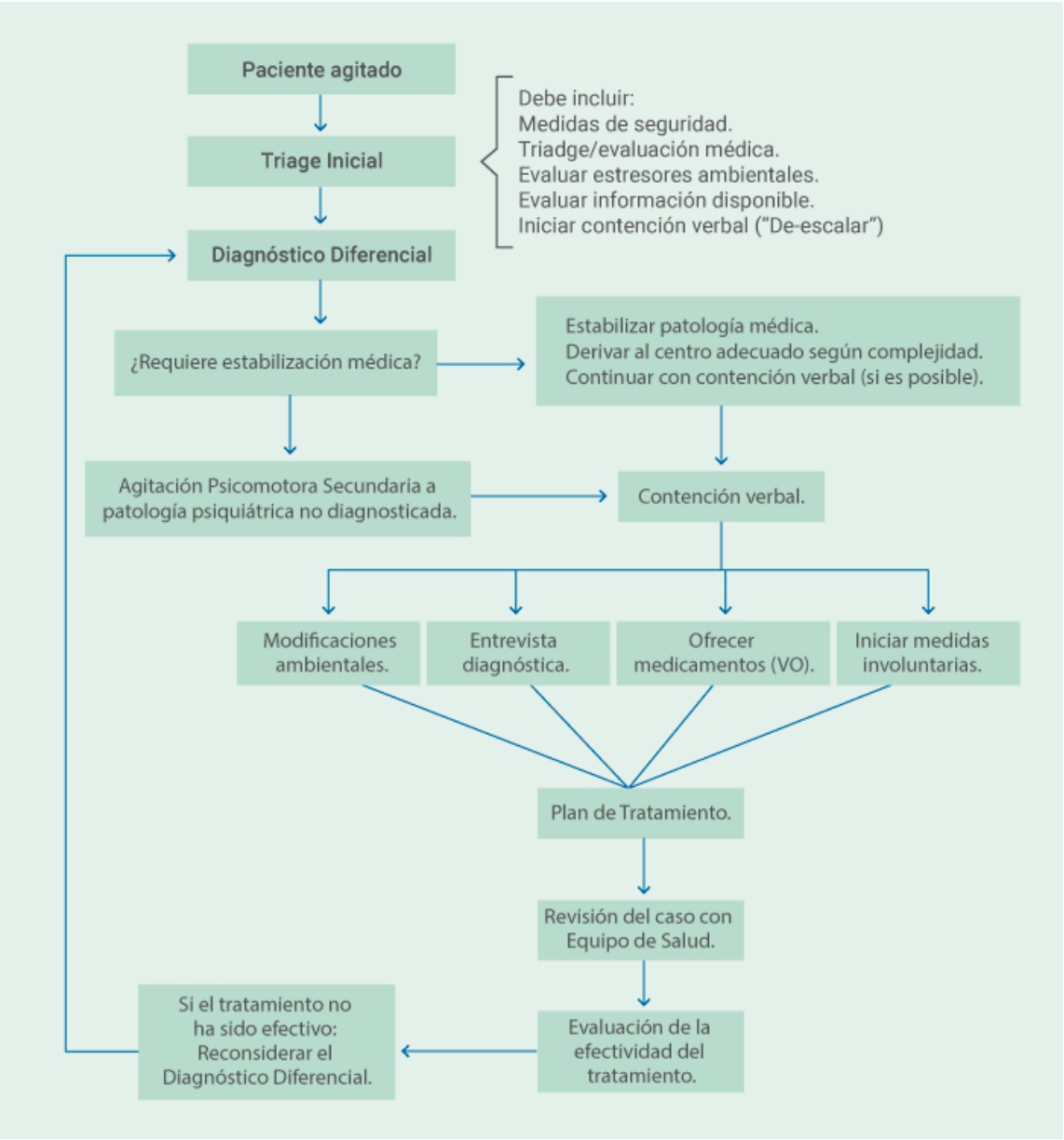
> Y... ¡preguntar siempre al paciente qué es lo que le está ocurriendo! Muchas veces el paciente desea hablar con el médico a cargo, para que le explique lo que está ocurriendo, o incluso puede necesitar algo de tomar o comer, o comunicarse con una familiar.

Intentar técnicas de contención verbal debe ser la primera medida a tomar, cuando las condiciones del paciente lo permitan, evitando la exposición a fármacos o medidas físicas que pueden ser innecesarias, y permitiendo además una evaluación in situ del nivel de agitación y del estado de conciencia del paciente.

Se sugiere que en la medida de lo posible el lugar físico para la evaluación tenga las condiciones de seguridad y ambientales necesarias, idealmente con menor ruido, temperatura y luminosidad.

Durante la evaluación siempre el médico a cargo del paciente debe ir preguntando e informando al paciente de los pasos que se están realizando, incluso en pacientes que se muestren agresivos.

En la siguiente figura se propone un flujograma de manejo del paciente que se presenta en la urgencia agitado (En New et al, 2017).



¿Es útil el manejo farmacológico de la Agitación?

Existe abundante literatura sobre qué alternativas farmacológicas utilizar en el paciente agitado[2]. Es fundamental considerar primero si existe claridad respecto de la patología que estamos tratando, sobre todo para aquellos pacientes en que la agitación sea secundaria a una causa orgánica ya demostrada.

Lamentablemente, en la mayoría de los pacientes que enfrentaremos en situaciones de agitación aguda el diagnóstico aún estará en proceso, y se presentarán como “casos no diferenciados” de agitación. Distinguir entre un paciente con un traumatismo encefalocraneal con una hemorragia cerebral, versus un paciente intoxicado con drogas o con efectos adversos de un medicamento, en una primera instancia, puede ser imposible.

Existen muchas opciones farmacológicas, con mucha controversia en la evidencia que sustenta su aplicación (Bak et al, 2019). Por este motivo es que presentaremos un abordaje práctico respecto de los medicamentos más utilizados y las dosis sugeridas para el manejo de un paciente adulto en general, pero queda el desafío para los clínicos de revisar en profundidad los casos particulares que pueden presentarse.

¿Contención verbal o farmacológica?

Siempre debemos partir con la contención verbal, utilizando técnicas para “De-Escalar” el conflicto, idealmente en un lugar más tranquilo, con menos ruido, con una temperatura y luminosidad más baja, condiciones muchas veces inexistentes en un servicio de urgencias.

Existen múltiples esquemas para ello, que se sugiere sean revisados en profundidad, excediendo el foco de esta clase.

Para profundización se sugiere ver:

Documento: *Joint BAP NAPICU evidence-based consensus guidelines...* VER

Quizás lo más importante es que cada equipo conozca una metodología de intervención para enfrentar situaciones conflictivas o de crisis.

Es necesario, entonces, usar un medicamento cuando la contención verbal no ha tenido resultado, o el paciente se encuentra extremadamente agresivo y poco receptivo a las intervenciones verbales, pero siempre “antes” de que se produzca una agresión física.

La escalada verbal es un buen predictor de una posible agresión física, por lo que la intervención debe realizarse de la manera más oportuna posible.

¿Cuál es el mejor fármaco para el manejo de la agitación?

No lo hay, pues no existe una sola opción, sino más bien hay ciertas características que debemos considerar al momento de definir si es necesario utilizar un medicamento, y la elección de cual.

Quizás la principal recomendación es utilizar la menor dosis efectiva (e idealmente por vía oral) para el paciente particular que estamos tratando, sin perder de vista su propia seguridad, la de nuestro equipo, y la del entorno.

La administración vía oral ha mostrado ser igualmente eficaz en el tratamiento de la agitación, al compararla con vía parenteral (New A., et al. 2017), por lo que se debe intentar y preferir por sobre la vía intramuscular, evitando además en lo posible la vía endovenosa.

A continuación revisaremos algunas características del paciente, de los medicamentos y de la presentación clínica a tener en consideración:

1. Algunas características del paciente:

- Edad del paciente: los adultos mayores pueden requerir hasta el 50% de las dosis habituales.
- Historia de antecedentes mórbidos: muchas veces información relevante se puede obtener de acompañantes.
- Intensidad de la agitación psicomotora.
- Historia previa de uso de medicamentos, y de uso exitoso de medicamentos en casos de agitación.
- Tratamiento de Base, en caso de recibirlo.
- Embarazo.
- Alergias.
- Colaboración del paciente: si colabora, utilizar fármacos por vía oral debe ser la primera opción.

En pacientes que rechazan medicamentos se pueden utilizar presentaciones sublinguales (benzodiazepinas) o dispersables en líquidos (como olanzapina).

2. Algunas características de los medicamentos:

Antipsicóticos:

Una de las familias de medicamentos más utilizadas para el manejo de la agitación en urgencias. Son una buena alternativa, sobre todo en pacientes con cuadros psiquiátricos a la base.

Se sugiere su uso de manera intramuscular, sublingual u oral, pero se intenta evitar la vía endovenosa dada su dificultad de acceso en el contexto de un paciente agitado y los riesgos que una vía puede provocar.

Los más utilizados en nuestro país son: de Primera Generación (o Típicos), el haloperidol, y la clorpromazina; y de Segunda Generación (o Atípicos), la olanzapina, y la risperidona, existiendo opciones menos utilizadas en urgencias como el aripiprazol, la ziprasidona y la quetiapina, potencialmente útiles.

> Entre un 55-92% de los pacientes refiere haber alcanzado la calma en 15-20 minutos con haloperidol, mientras que 66% reporta lo mismo con olanzapina."
>
> *Bak et al, 2019.*

Existe en nuestro país recientemente un antipsicótico de primera generación de uso inhalatorio, loxapina, que ha demostrado su utilidad en agitación, y que dada su vía de administración puede ser una alternativa poco invasiva a considerar.

La principal precaución de esta familia es su efecto extrapiramidal y la prolongación del intervalo QT en el Electrocardiograma (pese a que en general es clínicamente irrelevante, y en raras ocasiones puede relacionarse a Torsades de pointes).

Entre un 6-55% de los pacientes que recibe haloperidol experimenta síntomas extrapiramidales, y hasta un 17% puede presentar distonías agudas (Bak et al, 2019).

Esto mejora dramáticamente al asociar lorazepam a su administración. No más de un 5% de los pacientes que reciben olanzapina o risperidona reportan estos efectos.

Casos especiales consideran: el buen efecto de olanzapina en adultos mayores, dado su bajo riesgo de hipotensión y de síntomas extrapiramidales; y la seguridad de risperidona en el embarazo, sin riesgos teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre.

Benzodiazepinas:

Dado su efecto rápido, con un amplio margen de seguridad, y la posibilidad de rápida titulación en su dosis, son ampliamente utilizadas, tanto solas como en combinación con antipsicóticos.

Se deben considerar en pacientes cursando abstinencia a drogas, especialmente a estimulantes (cocaína, metanfetamina) y alcohol.

El principal efecto adverso será la excesiva sedación, asociada a depresión respiratoria, e hipotensión.

Los más utilizados en nuestro medio son el diazepam y el lorazepam, con reportes de buena respuesta sintomática en 78% de los pacientes, en 15-20 minutos (Bak et al, 2019), con potencial uso EV o IM. Además se puede considerar el uso de presentaciones sublinguales, de lorazepam y clonazepam.

El midazolam ha mostrado ser útil, con un efecto rápido, pero con alto riesgo de compromiso respiratorio, por lo que se debe restringir su uso a servicios de urgencia de alta complejidad.

Ketamina:

Es un fármaco anestésico, utilizado ampliamente para procedimientos en urgencias, intubación, incluso analgesia. Así mismo, tiene un excelente potencial para el manejo de la agitación psicomotora, especialmente en pacientes potencialmente violentos.

Requiere una mayor monitorización durante la duración del efecto, pero guías clínicas como la del Colegio Americano de Médicos de Urgencias la recomiendan en manejo de pacientes con patología psiquiátrica a la base[3]. Produce una adecuada respuesta, bastante rápida (4-5 minutos), lo que la hace indicada en casos de delirium “agitado” o hiperactivo (Miner et al, 2018).

El principal riesgo es que podría aumentar el requerimiento de intubación al comparar con haloperidol (lo que está en discusión actualmente), y que puede exacerbar los síntomas psicóticos en pacientes con cuadros crónicos, como la esquizofrenia. (New et al. 2017).

3. Algunas características de la presentación clínica, en caso de agitación por determinados diagnósticos:

Psicosis aguda

Antipsicóticos serán la opción a elegir. La combinación de antipsicóticos más benzodiazepinas puede dar más rapidez al control sintomático. No hay evidencia que permita recomendar una alternativa por sobre otra.

Intoxicación alcohólica versus síntomas de abstinencia

En una intoxicación será mejor considerar el uso de antipsicóticos, evitando la excesiva sedación que la mezcla del propio alcohol puede causar con las benzodiazepinas. Sin embargo, en la abstinencia de alcohol (que puede llegar al temido delirium tremens) se debe considerar el uso rápido de benzodiazepinas.

Intoxicación con estimulantes

Como cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, o cualquier simpaticomimético. Se debe considerar el uso rápido de benzodiazepinas, pero a veces con requerimientos mayores que las habituales.

Delirium Hiperactivo

Los pacientes agitados en el contexto de un compromiso del estado general y particularmente desorientados témporo-espacialmente, e inatentos, requieren una rápida intervención farmacológica, dado el alto riesgo de agresión física que pueden representar. Habitualmente se presentan de manera violenta, con escasa efectividad de las intervenciones verbales. El uso de ketamina podría ayudar a contener la situación en estos casos, por su efectividad y rápida acción.

Paciente agitado, pero no violento ni agresivo, sin respuesta a contención verbal

Siempre intentar medicamentos por vía oral, que han mostrado ser igualmente efectivos que por vía parenteral. Olanzapina sublingual es una buena alternativa, segura y efectiva.

La elección del medicamento debe considerar la presentación clínica del caso, la posible patología de base, y las características generales del paciente, según se ha descrito previamente. En la Tabla 2 se describen dosis sugeridas, a modo de guía general, y en ningún caso como pauta fija de indicaciones para todos los casos.

Tabla 2: Medicamentos, vía de administración, dosis, efectos adversos.

		Vía de Administración				
Familia de Medicamentos	Medicamentos	Oral (mg)	IM (mg)	EV (mg)	Inhalado (mg)	Efectos Adversos
Antipsicóticos de 1era Generación	*Haloperidol*	5-10	2.5-5	2.5-5	(-)	Síntomas Extrapiramidales, Distonía, Diskinesia Tardía
	Clorpromazina	100	25-50	(-)	(-)	Agranulocitosis, Hipotensión
	Loxapina	(-)	(-)	(-)	10	Convulsiones, Agranulocitosis, Hipotensión
Antipsicóticos de 2da Generación	*Olanzapina*	2.5-5*	2.5-10		(-)	Hipotensión ortostática, Sd Metabólico
	Risperidona	2-3	(-)	(-)	(-)	Similar a los AP de 1a Gración
	Ziprasidona	40-160	(-)	(-)	(-)	Similar a los AP de 1a Gración
Benzodiazepinas	*Lorazepam*	1-2*	2-4	2-4	(-)	Depresión Respiratoria
	Diazepam	5-10	2-10	2-10	(-)	Depresión Respiratoria
	Clonazepam	0.25*-2	(-)	(-)	(-)	Depresión Respiratoria

**Dosis en caso de uso Sublingual.*
Adaptado de New et al., 2017.

Existen flujogramas sugeridos para la elección de medicamentos en casos de agitación particular (Se sugiere revisar en De New et al, 2017).

¿Es necesario utilizar la contención física?

La contención física es un procedimiento mediante el cual se busca la sujeción del paciente que, dado el compromiso de su estado de conciencia, potencialmente puede ser peligroso para sí o terceros.

Es una medida extrema, que produce un gran impacto e incluso sufrimiento tanto al paciente como al equipo de salud encargado de su aplicación.

En el mundo, hoy se debate sobre la pertinencia, seguridad, e incluso legalidad de la contención física, a la luz del respeto de los derechos de los pacientes y lo traumática que puede resultar la contención física[4] . Casi un 55% de los pacientes que requieren contención física consideran que "fue una forma de agresión por parte del equipo de salud"[5].

Existe evidencia que permite afirmar que la contención física puede ser evitada en el caso de la agitación, y que ello debiese ser considerado una buena práctica en los servicios de urgencias.

Un 94% de los pacientes que fue sometido a una contención física consideró que "la situación podría haberse manejado de una manera diferente si el equipo de salud se hubiera tomado el tiempo de hablar, de abordar sus miedos y preocupaciones" en relación a la circunstancia que requirió de contención física (Rose et al, 2017).

Con todo lo anterior, cabe destacar que el uso de la contención física ha disminuido en las últimas décadas, al interior de los servicios de urgencias. (New et al, 2017). Esto, pues además de ser un acto potencialmente traumático, se relaciona a múltiples lesiones secundarias a la propia contención, así como el mayor riesgo de sufrir eventos adversos.

Algunos de los eventos adversos que pueden ocurrir en una contención física son:

Estos efectos adversos incluso pueden llegar a producir la muerte del paciente. Por otra parte, el equipo de salud se ve expuesto a lesiones traumáticas, oftalmológicas, y -sobre todo- a consecuencias emocionales negativas que se derivan de una contención física.

Por todos estos motivos, si usted puede evitar una contención física con un paciente en riesgo de agitación psicomotora, ¡evítela!

Pese a todo lo antes descrito, existen ciertas condiciones en que el paciente no es susceptible de la realización de una buena contención verbal, y donde se inicia el manejo farmacológico con escasos resultados. En estos casos puede ser inevitable la necesidad de realizar una contención física.

Para la realización de una contención física, es fundamental nunca perder de vista la seguridad, protección y dignidad del paciente agitado, así como la seguridad del equipo de salud, familiares y otros pacientes que puedan estar en la proximidad del procedimiento.

Lo más difícil de una contención física no es la realización del procedimiento, sino que la toma de decisión: indicarla, en el momento y lugar adecuados. El uso de la contención física debe ir rápidamente acompañado de la optimización del manejo farmacológico, buscando minimizar lo traumático de la situación para el paciente, así como el riesgo que se deriva de la propia contención).

Existen múltiples técnicas para la realización de este procedimiento. Se desaconseja la realización con uno o dos operadores, así como aquellas técnicas en que el paciente queda en decúbito prono, dado el mayor riesgo de asfixia y potencial muerte. Se recomienda que al menos participen 6 operadores para la realización de una contención, siendo uno de ellos el que guía y coordina el procedimiento.

Además, se deben utilizar medidas mecánicas adecuadas, una para cada extremidad, cuidando siempre no producir daño físico en el paciente con la sujeción.

Es necesario que cada centro clínico cuente con un protocolo de contención física, que además vaya de la mano de una correcta capacitación de los equipos clínicos, con prácticas supervisadas, y un acabado conocimiento de los recursos disponibles.

El protocolo además debe considerar control de signos vitales y del confort y bienestar del paciente en todo momento. En la figura 2 se observa cómo debe realizarse adecuadamente la contención física.

Figura 2: Ejemplo de contención física

Fuente: Obtenida de http://www.atensalud.com/2017/06/restriccion-terapeutica-fisica-mecanica.html

El personal a considerar para este procedimiento debe incluir al personal médico, de enfermería, de seguridad,

etc. Todo operador que participe de una contención debe haber recibido una adecuada capacitación, donde una de las directrices más importantes es que la contención es una indicación médica, pero que es guiada por un solo profesional durante la realización del procedimiento, que a la vez se mantiene realizando contención verbal hacia el paciente.

La contención física además debe considerar el uso de equipamiento adecuado para ella, así como de la monitorización de signos vitales necesarias, y la disposición de un espacio físico acorde. No se recomienda el uso de salas de aislamiento, que no proveen de más seguridad, sino que al contrario, pueden llevar a la omisión de complicaciones médicas graves e incrementar la traumatización del paciente y el equipo de salud por el procedimiento.

La temporalidad de uso de la contención física es clara: debe utilizarse por el menor tiempo posible (Mason et al, 2018). Una vez que el paciente se encuentra con contención física, debe ser examinado por el médico a cargo de inmediato, para detectar posibles lesiones secundarias al procedimiento.

Algunas recomendaciones internacionales apuntan a que la contención física no debe exceder las 4 horas en caso de adultos ó 2 horas en adolescentes (New et al, 2017). Se sugiere, además, siempre llevar un registro escrito de la condición del paciente durante el procedimiento.

Tras la contención, es necesario dedicar algo de tiempo a revisar el procedimiento con el equipo de salud, aclarar dudas y aprovechar de realizar contención emocional al equipo, a la vez de aprovechar la oportunidad para sugerir correcciones al procedimiento cuando se detecten fallas.También es importante volver a intentar la contención verbal del paciente, su familia, y otros pacientes que pudiesen haber presenciado el procedimiento.

Puntos Principales

- La agitación psicomotora es un síndrome clínico, que se define como la presencia de un aumento de la actividad motora, llegando a ser excesiva, y asociada a una sensación de tensión interna, y que se puede presentar hasta en un 5-10% de los pacientes que consultan en un servicio de urgencia.
- En general se produce en un continuo, en que inicialmente el paciente presenta inquietud o leve exaltación, que aumenta a agitación para finalizar en la agresión y violencia de la conducta agitada.
- Las causas de la agitación psicomotora son múltiples: secundaria a una patología orgánica (no-psiquiátrica), patologías psiquiátricas descompensadas, ingesta de sustancias exógenas (intoxicación, drogas de abuso), o incluso factores sociales.
- Se trata de una situación de distress para el paciente, sus familiares, pero también de una situación potencialmente peligrosa para el equipo de salud e incluso otros pacientes que se encuentren en el servicio de urgencia. Proteger la seguridad de todos los involucrados debe ser una prioridad al momento de enfrentarse al paciente agitado en el servicio de urgencia.
- El manejo de la Agitación debe balancear la necesidad de una precisión diagnóstica, con la seguridad del paciente y el equipo de salud.
- Se debe considerar siempre la contención verbal como primer paso, ofreciendo al paciente alternativas y diálogo que permita disminuir la exaltación que presenta.
- Si esto no funciona, se deben utilizar intervenciones farmacológicas y, en último caso, excepcionalmente, la contención física. La preparación del equipo de salud y de los centros sanitarios para esta emergencia médica es la principal manera de prevenir outcomes adversos no deseados.

Video Enfrentamiento del paciente agitado

Vea este video en la versión online de la clase.

Bibliografía Unidad 7

- Bak M, et al. The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis. Eur Psychiatry. 2019 Apr;57:78-100.
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). APA, 2013.
- Garriga M., et al. Assessment and management of agitation in psychiatry: Expert consensus. World J Biol Psychiatry. 2016;17(2):86-128.
- Gottlieb M. Approach to the Agitated Emergency Department Patient. J Emerg Med. 2018 Apr;54(4):447-457.
- Jones S, Howard L, Thornicroft G. 'Diagnostic overshadowing': worse physical health care for people with mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2008 Sep;118(3):169-71.
- Martínez G. Delirium: respuestas pendientes. Rev Hosp Clín Univ Chile 2008; 19: 330 - 8.
- Mason, Jessica et al. Agitation Crisis Control. Ann Emerg Med. 2018 Oct;72(4):371-373.
- Miner J, et al. The characteristics and prevalence of agitation in an urban county emergency department. Ann Emerg Med. 2018 Oct;72(4):361-370
- Nazarian D. et al. Clinical Policy: Critical Issues in the Diagnosis and Management of the Adult Psychiatric Patient in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2017 Apr;69(4):480-498.
- New A., et al. A Modern-Day Fight Club? The Stabilization and Management of Acutely Agitated Patients in the Emergency Department. Psychiatr Clin North Am. 2017 Sep;40(3):397-410.
- Rojas-Gambasica, J. et al. Validación transcultural y lingüística de la escala de sedación y agitación Richmond al español. Revista Colombiana de Anestesiología. 2016, 44(3), 216-221.
- Rose D, Perry E, Rae S, Good N. Service user perspectives on coercion and restraint in mental health. BJPsych Int. 2017 Aug 1;14(3):59-61.
- Strout T. Perceptions on the experience of being physically restrained: an integrative review of the qualitative literature. International Journal of Mental Health Nursing, 2010, 19, 416–427.